PROTOCOLLO 24

Igiene del sonno nel paziente con DTM

Migliorare la qualità del sonno per ridurre la sensibilità al dolore

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore persistente, bruxismo	10 minuti	Prime 3 sedute

Indicazioni

- ✓ Sonno non ristoratore
- ✓ Dolore al risveglio
- ✓ Bruxismo notturno sospetto

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo.

Fisioterapista: di fronte al paziente, con materiale illustrato.

Esecuzione passo dopo passo



Valuta

Orari, risvegli, dispositivi e qualità percepita.



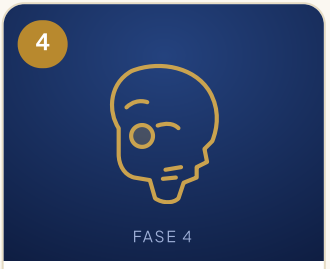
Routine

Orari regolari e attività rilassanti la sera.



Ambiente

Camera buia, silenziosa e senza schermi.



Posizione

Evita di dormire a pancia in giù con il volto compresso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Periodo	4 settimane
Diario	qualità del sonno da 0 a 10
Verifica	ogni 2 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il sonno scarso aumenta la sensibilità al dolore
- ✓ Cambiamenti piccoli e graduali
- ✓ Invia al medico se sospetti apnee

Errori da evitare

- ! Trascurare il russamento e le apnee
- ! Consigli generici senza piano
- ! Caffè e alcol serali non considerati

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Routine serale	Respirazione lenta e niente schermi 30 minuti prima di dormire	ogni sera

! **Nota clinica.** Disturbi del sonno e DTM si influenzano a vicenda; i sospetti di apnea vanno inviati allo specialista.

Bibliografia essenziale

1. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.
2. Moseley G.L., Butler D.S. Fifteen years of explaining pain: the past, present, and future. J Pain. 2015;16(9):807–813.